

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

LSAS · ESCALA DE ANSIEDAD SOCIAL DE LIEBOWITZ

Liebowitz Social Anxiety Scale – Patrón oro de evaluación bidimensional de miedo y evitación en Fobia Social

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS)
Autor Original	Michael R. Liebowitz (1987) - Columbia University / New York State Psychiatric Institute
Adaptación Española	Julio Bobes et al. (1999) y Olivares et al. (2002)
Tipo de Instrumento	Entrevista clínica heteroaplicada estructurada (o autoinforme validado LSAS-SR)
Población Diana	Adolescentes y adultos (>= 15 años) con sospecha o diagnóstico de Trastorno de Ansiedad Social (TAS)
Tiempo de Aplicación	15 a 25 minutos (24 reactivos pareados en miedo y evitación: 48 respuestas)
Formato de Respuesta	Doble escala Likert de 4 puntos: Miedo/Ansiedad (0-3) y Evitación conductual (0-3)
Finalidad Clínica	Evaluación diagnóstica dimensional de fobia social, diferenciación entre subtipo generalizado y circunscrito de actuación pública, y monitorización de respuesta al tratamiento farmacológico o cognitivo-conductual

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

Durante décadas, la fobia social fue considerada una entidad psicopatológica menor o una variante extrema de la timidez 性格. Michael R. Liebowitz revolucionó este campo conceptual en 1987 al postular que el Trastorno de Ansiedad Social es una condición grave e invalidante caracterizada por un terror patológico al escrutinio ajeno, a la evaluación negativa y a la posibilidad de comportarse de forma humillante o embarazosa.

La LSAS se sustenta sobre un diseño bifactorial y bidimensional riguroso: evalúa simultáneamente dos constructos emocionales complementarios – la intensidad subjetiva del miedo experimentado y la frecuencia de la conducta de evitación desplegada para escapar de la situación– a lo largo de dos dominios contextuales cardinales: a) **Situaciones de Interacción Social** (conversar con personas de autoridad, iniciar una charla con un desconocido, asistir a una fiesta); y b) **Situaciones de Rendimiento o Desempeño Público** (hablar en público, comer o beber delante de otros, escribir mientras alguien observa o utilizar un urinario público).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dominio Situacional	Nº Ítems	Ítems Constituyentes y Contenido Específico
Interacción Social (IS)	11 ítems	Ítems 5, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24: Iniciar conversaciones, mantener contacto ocular, devolver compras, ligar y hablar con extraños.
Rendimiento / Público (P)	13 ítems	Ítems 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21: Hablar en público, comer/beber ante otros, escribir observador, actuar y usar baños públicos.
Puntuación Total LSAS	24 ítems	Suma Miedo Total (0-72) + Evitación Total (0-72) = Rango Total de 0 a 144 puntos.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · LSAS

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach extraordinario en población clínica española (Bobes et al., 1999): Miedo Total = 0.95; Evitación Total = 0.94; LSAS Total = 0.97.
Fiabilidad Test-Retest	Coeficiente de correlación intraclass ICC = 0.89 a 0.92 en intervalos de dos semanas en pacientes en lista de espera.
Validez Diagnóstica (ROC)	Con punto de corte total de 30 puntos para cualquier Fobia Social: Sensibilidad = 92%, Especificidad = 87%, AUC = 0.94 frente a SCID-I. Para el subtipo Generalizado el punto de corte óptimo es ≥ 60 .
Validez Concurrente	Correlación elevada con la Social Phobia Scale (SPS, $r = 0.79$), la Social Interaction Anxiety Scale (SIAS, $r = 0.81$) y el SPIN ($r = 0.84$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Calificación de Miedo / Ansiedad (Columna Izquierda):**
 - 0 = Ninguno; 1 = Leve; 2 = Moderado; 3 = Grave. (Suma máxima: 72 puntos).
- Calificación de Evitación (Columna Derecha):**
 - 0 = Nunca (0%); 1 = Raras veces (1-33%); 2 = A menudo (34-67%); 3 = Habitual / casi siempre (68-100%). (Suma máxima: 72 puntos).
- Subtotales Específicos:**
 - Miedo a Interacción Social (0-33) y Miedo a Rendimiento (0-39).
 - Evitación de Interacción Social (0-33) y Evitación de Rendimiento (0-39).
- Puntuación Total Compuesta:** Suma de Miedo Total + Evitación Total (Rango: 0 a 144 puntos).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Estratificación	Subtipo Clínico	Directriz Asistencial y Psicoterapéutica
0 a 29 puntos	Normal / Sin TAS	Asintomático	No existe fobia social. Sin necesidad de tratamiento.
30 a 59 puntos	Fobia Social Leve-Mod.	Circunscrito / Ejecución	TCC grupal o entrenamiento en habilidades de actuación.
60 a 89 puntos	Fobia Social Marcada	TAS Generalizado	TCC estructurada de Heimberg o Clark / ISRS (sertralina).
90 a 144 puntos	Fobia Social Grave	Severo / Incapacitante	Tratamiento multimodal intensivo; riesgo de depresión y abuso.

DISCRIMINACIÓN DE SUBTIPOS CLÍNICOS (LSAS ≥ 60): El punto de corte de 60 puntos separa con gran fiabilidad la fobia social circunscrita a situaciones de desempeño público (hablar en público, presentaciones) del Trastorno de Ansiedad Social Generalizado, el cual afecta a la mayoría de las interacciones cotidianas y suele asociarse a personalidad evitativa comórbida.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · LSAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Administración Heteroaplicada: Evaluar situaciones temidas y conductas de evitación activas.

Paso 2: Conducta Asistencial según Puntuación y Subtipo:

- **Si LSAS 30-59 (Fobia Social Específica / Rendimiento):** Psicoterapia cognitivo-conductual con exposición graduada. En ansiedad de ejecución circunscrita (músicos, oradores), valorar betabloqueantes en dosis puntual (propranolol 10-20 mg 1 hora antes del evento).
- **Si LSAS $\geq$ 60 (Fobia Social Generalizada):**
 1. Instaurar tratamiento farmacológico de primera línea con ISRS (sertralina 100-150 mg/día o paroxetina 20-40 mg/día) o venlafaxina.
 2. Psicoterapia Cognitivo-Conductual (modelo Clark & Wells): eliminación del procesamiento post-evento y del foco atencional autofocalizado mediante experimentos conductuales con videograbación.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 26 años, graduada en informática, acude a salud mental tras rechazar un ascenso laboral que le obligaba a interactuar en reuniones con clientes extranjeros. Refiere aislamiento social progresivo desde la adolescencia.

Evaluación Psicométrica Inicial en LSAS: Total = 84 / 144 puntos (Miedo = 44, Evitación = 40; Fobia Social Marcada / Generalizada).

- **Interacción Social:** 42 / 66 puntos. Pánico y evitación casi total a mantener contacto visual con desconocidos (ítem 19 = 3/3), hablar con jefes (ítem 10 = 3/3) o devolver ropa en tiendas (ítem 15 = 2/3).
- **Rendimiento:** 42 / 78 puntos. Rubor facial severo, sudoración y temblor de manos al comer frente a compañeros (ítem 2 = 3/2) o hablar en público (ítem 16 = 3/3).

Manejo Clínico: Se diagnosticó Trastorno de Ansiedad Social Generalizado con Trastorno de la Personalidad Evitativa comórbido. Se pautó sertralina 100 mg/día combinada con terapia cognitivo-conductual individual y posterior integración en grupo de habilidades sociales. Se utilizaron tareas de exposición in vivo al rechazo social (preguntar direcciones absurdas) y dismantelamiento de conductas de seguridad (no maquillarse para ocultar el rubor). A los 6 meses, la LSAS descendió a 28 puntos, aceptando la paciente el puesto laboral directivo.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE COMORBILIDAD

- Alto riesgo de consumo perjudicial de alcohol como ansiolítico desinhibidor social ("beber para poder salir de fiesta"); investigar con ISCA o AUDIT.
- Elevada comorbilidad con depresión mayor y riesgo suicida por desesperanza ante el aislamiento crónico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Agorafobia:** El miedo es a no poder escapar o no recibir auxilio en caso de crisis de pánico, no a la evaluación del juicio ajeno.
- **Trastorno del Espectro Autista (TEA Leve):** Dificultades primarias en comunicación social pragmática sin deseo de integración que suele existir en el fóbico social.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Liebowitz, M. R. (1987). Social phobia. *Modern Problems of Pharmacopsychiatry*, 22, 141–173.
- Bobes, J., Badía, X., Luque, A., García, M., González, M. P., Dal-Ré, R., & Grupo de Validación en Fobia Social. (1999). Validación de las versiones en español de los cuestionarios Liebowitz Social Anxiety Scale, Social Anxiety and Distress Scale y Fear of Negative Evaluation Scale para la evaluación de la fobia social del adulto. *Medicina Clínica*, 112(14), 530–538.
- Heimberg, R. G., Horner, K. J., Juster, H. R., Safren, S. A., Brown, E. J., Schneier, F. R., & Liebowitz, M. R. (1999). Psychometric properties of the Liebowitz Social Anxiety Scale. *Psychological Medicine*, 29(1), 199–212.
- Clark, D. M., & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In R. G. Heimberg, M. R. Liebowitz, D. A. Hope, & F. R. Schneier (Eds.), *Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment* (pp. 69–93). Guilford Press.